

07 - 07- LE RÉTINOBLASTOME - Pr. MOUTAOUAKIL

(0:02 - 1:01)

Bonjour à notre chapitre particulier que j'ai tenu à enseigner à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech en ophtalmologie, parce que je pense que c'est un chapitre qui mérite énormément d'attention, c'est parce que d'abord il s'agit d'un cancer et un cancer au niveau oculaire qui menace le pronostic vital. Donc je vais essayer d'être rapide et surtout de vous enseigner ce cours du ritinoblaston en images pour pouvoir donc passer un certain nombre de messages pour le dépistage précoce et surtout pour avoir un pronostic beaucoup plus favorable. Nous allons voir une introduction, la physiopathologie du ritinoblaston sur le plan génétique, comment il se manifeste, diagnostic positif, diagnostic différencié et un petit mot sur les traitements.

(1:02 - 4:17)

Le ritinoblaston est la tumeur maligne oculaire la plus fréquente de l'enfant. Son incidence évidemment de 1 sur pour 15 000 jusqu'à 1 pour 20 000 naissances avec un sexe ratio de 1,5 sur 1. Il faut savoir que dans le ritinoblaston, il existe deux formes bien distinctes. Il y a les tumeurs unilatérales en bleu qui représentent quand même 60% des personnes qui sont les plus fréquentes.

Il survient à un âge un petit peu plus avancé, 2 ans, 3 ans jusqu'à 4 ans et souvent non héréditaire. Les tumeurs bilatérales qui sont de 40%, ils surviennent de façon plus précoce même parfois avant l'âge d'un an et ils sont toujours héréditaires. Voici des exemples de jeunes, un petit peu plus avancés pour le ritinoblaston unilatéral, 60 à 75%, 2 à 3 ans, pas d'hérédité et le ritinoblaston bilatéral, on le retrouve souvent chez des patients moins jeunes, 6 à 18 mois, 25 à 40%, l'hérédité, elle est très présente.

Sur le plan physiopathologique, la ritine et la couche interne, des signes situés à l'arrière du globoculaire, le ritinoblaston est un modèle de développement tumoral par défaut d'antigènes oncogènes, c'est le gène Herbert, qui joue un rôle suppresseur de la tumeur. Donc lorsque ce gène se gène, déjà il est situé au niveau du bralon du chromosome 1, bande 13Q, 1.4, un rôle majeur dans la régulation du cycle cellulaire, donc une cellule ritinienne normale, il y aura le Herbert, le gène qui code pour le Herbert. Lorsque le chromosome 13 avec une délétion de ce locus qui représente, il y aura un risque de développer donc un ritinoblaston et parfois lorsqu'il n'y a plus cette délétion, les deux chromosomes, donc il y a un risque de développement de ritinoblaston.

Sur le plan clinique, comment va se manifester le ritinoblaston? Il va se manifester par le lochochoriste, le film populaire d'Anchâtre œil de chat, la visualisation directe de la tumeur à travers l'air pupilaire qui doit nous attirer vers le ritinoblaston. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de vision

au niveau des cétèles, donc ces cétèles vont être déviées, il y aura un strabisme qui traduit une mauvaise vision, il devient rapidement constant. Un strabisme même intermittent impose une consultation urgente d'ophtalmologie avec examen, donc du fondeur.

(4:17 - 4:44)

D'autres circonstances sont plurielles, des formes évoluées, exophtalmie, hétérochromie aérienne, buvthalmie, cellulite orbitale, FMA, pseudo-épopée. Parfois, l'examen systématique, sujet arrêté, risque porteur de la mutation du gène RP1, la fratrie d'un nourrisson porteur d'un ritinoblaston bilatéral. Voici donc des cas rares qu'on a observés au niveau du cergeuis, de complication, FMA.

(4:44 - 6:02)

Retenez, c'est le locochoriste, le strabisme, ce sont très rares et malheureusement, on continue encore à les voir dans notre contexte. Ce sont des cas très évolués, très compliqués. Voilà un ritinoblaston qu'on voit ici.

Le diagnostic le plus souvent effectué lors d'un examen du fondé sous anesthésie générale au milieu spécialisé, une tumeur blanche, jaunâtre, crible, crayeuse, parsemée de foyers de classification et vascularisée en surface. On distingue trois formes cliniques, l'endophytique, l'exophytique et l'infiltrant diffus. Ça c'est une affaire du spécialiste.

Voici l'endophytique qui apparaît à l'intérieur de l'œil, voici l'exophytique et voici la forme infiltrante. L'examen des parents à la recherche de formes régressives héréditaires, l'examen de sujets à risque, porteur de délétions de gènes RB1, l'œil ADEL d'un enfant porteur d'un retinoblastome inaltéral ou la fratrie d'un enfant porteur de retinoblastome. La collaboration entre pédiatres, oncologues, radiologues, pédopsychiatres, généticiens et anapathes est essentielle pour une meilleure prise en charge pour l'enfant et son entourage.

(6:02 - 8:37)

Parfois l'icographie est très intéressante dans le diagnostic lorsqu'il montre une tumeur intraoculaire avec des calcifications intralésionnelles. L'ATDM et l'IRM permettent de remarquer les calcifications intralésionnelles et l'étendue lecorréionnelle. La teinte du quiasma est un retinoblastome très latéral aussi qui peut parfois être observé.

Sur le plan paraclinique, l'anapathe va montrer des cellules de petite taille ronde, polygonales, en amandance, en rosettes, surtout en rosettes très caractéristiques, un noyau volumineux hyperchromatique, très basophile, avec de nombreuses mitoses. Plusieurs classifications ont été utilisées. Sur cette image, c'est la classification d'Ernst-Helsworth qui permet de classer les tumeurs selon son importance, groupe 1, groupe 2, donc ça c'est des détails, la classification aussi internationale élaborée récemment et qui parle donc de la teinte extra-oculaire qui permet donc de classer les tumeurs.

Ça c'est essentiellement pour les traitements. Voici donc un retinoblastome sur une très belle pièce de nucléation. Lorsqu'on enlève l'œil et on l'envoie à l'anapathie et il fond, donc la coupe macroscopique on voit donc ces tumeurs blanchâtres qui est assez caractéristique.

Alors, les groupes du retinoblastome, c'est pour vous parler du groupe A, petit tumeur inférieure 3 mm localisé au niveau de la rétine, loin de la foveola du disque optique. Groupe B, petit tumeur confiné à la rétine, mais proche du disque optique de foveola. Groupe B, tumeur supérieure 3 mm confiné à la rétine.

Groupe C, tumeur avec liquide sur rétine à extension locale. Groupe D, tumeur avec liquide sur rétine diffuse à extension sous-rétine. Regardez un autre, groupe D avec une tumeur avec extension diffuse.

Et le groupe E, tumeur dans le segment antérieur. Les principaux diagnostics différentiels sont les cataractes chez l'enfant. La cataracte est la plus fréquente, mais éliminée en retinoblastome d'abord.

(8:37 - 9:36)

Le strabisme fonctionnel, eau organique chez l'enfant, la maladie d'occuluse, atteinte rétine ulcéraire plus fréquente chez le garçon, l'infestation en toxocara, la persistance de vitrines primitives, certaines formes d'hivélite, intérêt des examens, donc complément. Sur le plan thérapeutique, le traitement, il y a des traitements conservateurs et des traitements non conservateurs. Les traitements conservateurs peuvent faire appel à la cryo, à la thérapie transpupillaire, à la chimiothérapie, à la radiothérapie.

Malheureusement, lorsque la tumeur est très importante, on est obligé de faire soit une nucléation, une mini-exantération ou une exantération. Voici une nucléation, on a nickelé le globe, on a mis une bille à la place qui peut remplacer l'œil. Regardez une rétine oubliée-stompe opérée, une nucléation avec prothèse, on dirait que l'œil ne présente rien.